جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : نعام جميل جبرة جريس
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** مدينه نصر الاول **العنوان :** ----------
رقم البطاقة : 27412092501548 **رقم التليفون :** 01003391388 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 24-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 09-12-1974 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضي الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونيك [14157] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: نعام جميل جبرة جربس
National ID: 27412092501548

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPT

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات
ودعم القرار

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION AND DECHON SUPPORT

تاريخ الاصدار :2023-5-25

جهه الاصدار :فرع القاهرة

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمرأة المعيله .

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين أن

السيد (ة) نعام جميل جبره بطاقة رقم 27412092501548

وطبقا الى خطاب من التأمينات الإجتماعية يفيد عدم الأنتفاع

يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحى صدر هذا الخطاب دون اى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحى الشامل

وشكرا

تاريخ الطباعه :2023-5-25

الموظف المختص
دينا عماد

افادة مركز نظم المعلومات
يعتمد،،،

مسلسل 741262

الخطاب سارى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حاله تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعى أو وزراة التربية و التعليم

الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات و دعم القرار

اوراق استكمال قرارات حفظة الدولة

Non-HIO Letter
[[DOCTYPE:NON_HIO_LETTER]]

Name: نعام جميل جبرة جريس	
MR. : 6000	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient was continued on ARAMIDEX with supplemental therapy, and laboratory monitoring was ordered for estradiol (E2) and follicle-stimulating hormone (FSH) at the three-month interval. Based on those results, the plan was to initiate ZOLADEX and to schedule ZOMETA for the next visit after the labs are reviewed.

The patient has a history of breast cancer with post-mastectomy findings including residual disease on left mammogram dated 4/11/2023. Pathology reported a grade 3 tumor with nodal involvement (N1) and hormone receptor status positive (ER 7/8, PR 4/8, HER2 2+). The patient previously received Kadcyla in September 2024, Arimidex initiated in December 2023, and a Zometa infusion in April 2026. Current systemic therapy includes PHESGO, which was started on 4/11/2023. The plan is to continue monitoring disease status and manage supportive care as indicated.

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : اسماء محمد مصطفي نصر

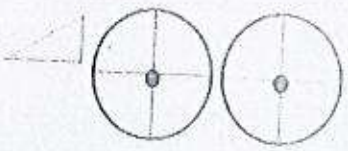
يعتمد ,

Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

MDT form

A-Patient ID:
1- Name : نعام جميل جيره جرجس
Sex: Female
3- Medical number: 83140298
Old Med : 1624-2023
2-ID number: 27412092501548
Patient Age : 49 Y



Family history	Family History	Phone	Phone 01203359235	BMI	BMI 31	REASON OF MDT	REASON OF MDT POST OPERATIVE
marital status	Marital Status MARRID	NRS Score	NRS Score	GROUP	GROUP C	Date of MDT	Date of MDT 10/12/2023
Co morbidity	Co Morbidity BRONCHIAL ASTHMA	Menopausal status	Menopausal Status POSTMENOPAUSAL	Initial STAGE	Initial STAGE		

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup : FREE

BX	ER	PR	Her 2 Neu	SISH	Ki67
IDC BX COMMENT:	7/8 ER COMMENT:	4/8 PR COMMENT:	3 Her 2 Neu COMMENT:	SISH COMMENT :	3

T	N	M
3	1	0

Sonomammography

LT BREAST UOQ AND LOQ LITTLE EXTENT TO LIQ 4.5X2.5 CM

PATIENT HISTORY

received 6 cycles taxotere / carbo+4 cycles HP
ON EXAM AND BY REVIEWING MAMMOGRAM IMAGES THERE IS PROGRESSION IN BREAST MASS
lt mrm

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

KADCYLA, E2 AND FSH, ZOLADEX, AI, PORT

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY د/ هلان عزت د/ رضوي صبره	RADIOLOGY	RADIOLOGY د/ امل حجازي
SURGERY	SURGERY	PATHOLOGY	PATHOLOGY
Psychiatric	Psychiatric	Nutrition	Nutrition

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

سمارت سكان
للأشعة والرنين المغناطيسى
WE CARE SMARTLY

Name: En'aam Gamil Gabra	Date: 06/05/2023
Pat. Age: 45 Year(s)	Dear Prof. Dr.:
Pat. ID: 1611674	Thank you for referring this case.:

MDCT SCAN OF THE ABDOMEN AND PELVIS WITH INTRAVENOUS CONTRAST (TRIPHASIC TECHNIQUE) :



- **Known case of left breast cancer, the current study revealed:**
- **The liver shows mild enlarged size , fatty CT pattern ,** displaying homogeneous parenchymal density. **No focal lesions.**
- GB no dense stones, no mud , no masses .
- No evidence of dilated intra-hepatic biliary radicals detected.
- The spleen shows average in size displaying normal homogeneous CT density. No evidences of splenic masses or cysts detected.
- The pancreas shows average size displaying normal CT density. No evidences of pancreatic masses or cysts detected, clear peri-pancreatic fat planes.
- Both kidneys appear average in size displaying normal parenchymal appearance. No evidences of renal masses, stones, no back pressure changes detected, good excretory function seen
- Normal stomach, bowel loops with no apparent abnormalities .
- UB shows average wall thickening, no masses, no stones.
- Uterus and ovaries are of average size and shape with no masses nor cysts.
- **No bony sclerotic or lytic bony deposits.**
- **Bilateral mild sacroiliitis .**
- **Transitional lumbo-sacral vertebra, partially sacralized L5 vertebra with right sided pseudoarthrosis .**

٢شارع أحمد الزمر- ميدان الحى العاشر-مدينة نصر
www.smartscan-eg.com
٠١٢٠ ٢٢٦ ٤٤٤٤
ت:٠٤١٧ ٣٠ ٢٤٧ م: ٠١١٢٣٠٩٠٤٠٠ - ٠١٠١٠٨٠٥٠٦٢

سمارت سكان
للأشعة والرنين المغناطيسى
WE CARE SMARTLY

Name: En'aam Gamil Gabra	Date: 06/05/2023
Pat. Age: 45 Year(s)	Dear Prof. Dr.:
Pat. ID: 1611674	Thank you for referring this case.:

Opinion

- Known case of left breast cancer
- No evidence of any abdominal organ deposits.
- Fatty hepatomegaly.
- Bilateral mild sacroilliitis .
- Transitional lumbo-sacral vertebra , partially sacralized L5 vertebra with right sided pseudoarthrosis .

Much Obliged, Yours
Dr. Islam Salah,MD

٢شارع أحمد الزمر- ميدان الحى العاشر-مدينة نصر
www.smartscan-eg.com
ت: ٤١٧ ٣٠ ٢٤٧ م: ٠١١٢٣٠٩٠٤٠٠ - ٠١٠١٠٨٠٥٠٦٢
٠١٢٠ ٢٢٦ ٤٤٤٤

سمارت سكان
للأشعة والرنين المغناطيسى
WE CARE SMARTLY

Name: En'aam Gamil Gabra	Date: 06/05/2023
Pat. Age: 45 Year(s)	Dear Prof. Dr.:
Pat. ID: 1611674	Thank you for referring this case.:

MDCT SCAN OF THE CHEST WITH CONTRAST REVEALED:-

- **Known case of left breast cancer, the current study revealed:**
- **Left breast shows diffuse skin and subcutaneous tissue edema associated with multiple enlarged pathological enlarged LNs , largest 22 mm .**
- No pulmonary patches.
- No pulmonary consolidation, cavitary or infiltrative lesions.
- **No pulmonary masses or sizeable nodules.**
- Few basal linear thin atelectatic bands .
- No hilar or mediastinal masses or significant lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection.
- Patent trachea and major tracheo-bronchial airways.
- Intact bony thoracic cage.
- Normal CT appearance of the heart and great vessels.
- No bony sclerotic or lytic bony deposits .

Opinion

- **Known case of left breast cancer**
- **Left breast diffuse skin and subcutaneous tissue edema associated with multiple enlarged pathological enlarged LNs .**
- **No evidence of any thoracic organ deposits .**
- **Few basal linear thin atelectatic bands .**

Much Obliged, Yours
Dr. Islam Salah,MD

٢شارع أحمد الزمر- ميدان الحى العاشر-مدينة نصر
www.smartscan-eg.com
٠١٢٠ ٢٢٦ ٤٤٤٤
ت:٠٤١٧ ٣٠ ٢٤٧ م: ٠١١٢٣٠٩٠٤٠٠ - ٠١٠١٠٨٠٥٠٦٢
CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

PATIENT NAME: **Naam GAMIL GABRA GRAS**	PATIENT ID #: **10123227128**
GENDER: **Female**	ORDER #: **2349040**
AGE: **48 y**	DATE OF SERVICE: **17-Jun-2023 04:02 PM**

Report:

99mTc-MDP BONE SCAN

Desired Information: - skeletal survey.

Technique:

Delayed Whole body imaging in anterior and posterior projection performed 2 minutes & 2 hours after I.V administration of 20 mCi 99mTc-MDP:

FINDINGS:.

Degenerative changes at dorso- lumbar vertebrae.

Arthritic changes at knees and shoulders.

Otherwise, no hot or cold spots that would account for serious bone lesions.

Both kidneys are seen.

Conclusion: -

No definite evidence of metastatic osseous deposits.

Follow up bone scan is advised.

Reported By,

Ass. Prof. Huda Fathy Elsayed **18-Jun-2023 03:56 PM**

www.baheya.org 16602 شارع علوية متفرع من شارع الهرم

Patient Name	: الأستاذه / نعام جميل جبره	Request No.	: 13003964
Patient No.	: 27412092501548	Request Date	: 13/05/2023
Path No.	: SR-577/23	Verification Date	: 21/05/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 48 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Right breast mass.
Nature of Specimen: Slide Revision

Gross examination:
- Five slides labeled by (570007) slides were received.

Microscopic Examination:
* Histological type: Invasive duct carcinoma, micropapillary type.
* Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): Grade II (3+2+ 1)
* DCIS: Focal DCIS.
* Angioinvasion: No.
* Perineural invasion: No.
* IPT:
- ER: Strong nuclear reaction in 70% of tumor cells (Allred score 8 /8).
- PR: Moderate nuclear reaction in 7% of tumor cells (Allred score 4 /8).
- Her2: Strong complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 3+).
- Ki67: 35% nuclear reaction of tumor cells.

Diagnosis:
Right breast cancer, Slide revision:
- Invasive duct carcinoma G II, micropapillary type with focal DCIS.
IPT:
- ER: Positive (score 7/8).
- PR: Positive (score 4/8).
- Her2: Positive (score 3+).
- Ki67: Positive in 35% of tumor cells.

قسم الباثولوجي

Signature

Verified by :
DR.Menna Nabil

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (957) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor Building No. 957 - Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذه / نعام جميل جبره	Request No.	: 13000995
Patient No.	: 27412092501548	Request Date	: 06/11/2023
Path No.	: 3910/23	Verification Date	: 19/11/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 48 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Ali mostafa

Pathology Report

Diagnosis:
Left breast cancer post NACT, MRM specimen:
* Invasive duct carcinoma GII with micropapillary features.
- Maximal tumor diameter 7.5x3.5 cm
- Actual tumor cellularity: 75%, tumor necrosis index: 25%
* Minimal DCIS <5%.
* Free nipple and areola.
* Lymph nodes were positive in (11/21 with extracapsular extension).
* Free deep margin.
* Partial pathological response to therapy.
- Stage: ypT3, ypN3.
- RCB: 4.58 , RCB class III.

Signature
Prof. Dr. Lubna Omar.
Dr. Menna Nabil.

Verified by :
DR.Menna Nabil

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

WE CARE SMARTLY

Name: En'aam Gamil Gabra	Date: 06/05/2023
Pat. Age: 45 Year(s)	Dear Prof. Dr.:
Pat. ID: 1611674	Thank you for referring this case:

MDCT SCAN OF THE CHEST WITH CONTRAST REVEALED:-

- Known case of left breast cancer, the current study revealed:
- Left breast shows diffuse skin and subcutaneous tissue edema associated with multiple enlarged pathological enlarged LNs , largest 22 mm .
- No pulmonary patches.
- No pulmonary consolidation, cavitary or infiltrative lesions.
- No pulmonary masses or sizeable nodules.
- Few basal linear thin atelectatic bands .
- No hilar or mediastinal masses or significant lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection.
- Patent trachea and major tracheo-bronchial airways.
- Intact bony thoracic cage.
- Normal CT appearance of the heart and great vessels.
- No bony sclerotic or lytic bony deposits .

Opinion

- **Known case of left breast cancer**
- **Left breast diffuse skin and subcutaneous tissue edema associated with multiple enlarged pathological enlarged LNs .**
- **No evidence of any thoracic organ deposits .**
- **Few basal linear thin atelectatic bands .**

Much Obliged, Yours
Dr. Islam Salah, MD

CT Scan
[DOCTYPE CT SCAN]

٠١٢٠ ٢٢٦ ٤٤٤٤
٠١٠١٠٨٠٥٠٦٢ - ٠١١٢٣٠٩٠٤٠٠ ت: ٤١٧ ٣٠ ٢٤٧ ف:
ثكارم أحمد الزمر - ميدان الحي العاشر - مدينة نصر
www.smartcare.com.eg

PATIENT NAME: Naam GAMIL GABRA GRAS	PATIENT ID #: 10123227128
GENDER: Female	ORDER #: 2349040
AGE: 48 y	DATE OF SERVICE: 18-Jun-2023 04:02 PM

Report:

99mTc-MDP BONE SCAN

Desired Information: - skeletal survey.

Technique:

Delayed Whole body imaging in anterior and posterior projection performed 2 minutes & 2 hours after I.V administration of 20 mCi 99mTc-MDP.

FINDINGS:.

Degenerative changes at dorso- lumbar vertebrae.

Arthritic changes at knees and shoulders.

Otherwise, no hot or cold spots that would account for serious bone lesions.

Both kidneys are seen.

Conclusion: -

No definite evidence of metastatic osseous deposits.

Follow up bone scan is advised.

Reported By,

Ass. Prof. Huda Fathy Elsayed 18-Jun-2023 03:56 PM

www.baheya.org 16602
Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]

Patient Name	:الأستاذه / نعام جميل جبره	Request No.	:13000995
Patient No.	:27412092501548	Request Date	:06/11/2023
Path No.	:3910/23	Verification Date	:19/11/2023
Sex	:Female	Financial Category	:اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	:48 Y	Department	:Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	:Ali mostafa

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, post NACT.

Nature Specimen: Left modified radical mastectomy specimen.

Gross Examination:
* Procedure: Left MRM measured 23x18x4 cm with covering skin ellipse measured 23x12 cm.
* Tumor extent: A greyish white ruberry tumor bed site.
* Size: 7.5 x3.5 x3 cm.
* Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly.
* Distance from margins: 3 cm away from deep margin.
* Lymph nodes number and size: Axilla measured 8x6x2 cm, entangling 21 L.Ns up to 2x2 cm.

Microscopic Examination:
* Histological type: Invasive duct carcinoma with micropapillary features.
* Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) Grade II.
- Maximal tumor diameter 7.5x3.5 cm
- Actual tumor cellularity: 75%, tumor necrosis index: 00%
* Ductal carcinoma in situ: Minimal DCIS <5%.
* Lymphovascular emboli: Occasional.
* Skin involvement: Free nipple and areola.
* Lymph node involvement: positive in (11/21 with extracapsular extension).
* Resection Margins: Free deep margin.
* Histologic response to therapy: partial pathological response.
* Microcalcifications: yes.
* Additional pathologic findings: Necrosis.

Verified by :
DR.Menna Nabil

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]



National ID – Front
[[DOCTYPE:ID_FRONT]]

National ID – Back
[[DOCTYPE:ID_BACK]]

